

## EXÁMEN RESIDENCIAS MÉDICAS

---

LLAMADO A EXAMEN ÚNICO PARA SELECCIÓN DE  
RESIDENTES – 2017

Cuadernillo: MEDICINA BÁSICO - A

1) El tratamiento quirúrgico del cáncer de colon de derecho es:

A- Hemicolectomía derecha.

B- Colectomía total.

C- Operación de Hartmann.

D- Cecostomía.

---

2) ¿A qué se denomina operación de Billroth I?

A- Gastrostomía.

B- Anastomosis gastroduodenal.

C- Anastomosis gastroyeyunal.

D- Anastomosis gastrocólica.

---

3) El DOLOR PARIETAL tiene como característica:

A- Se produce por contracción de fibras musculares lisas.

B- Tiene localización errática.

C- Es intermitente.

D- El paciente lo localiza con exactitud.

---

4) ¿Cuál es la manifestación más frecuente en los pacientes con litiasis biliar?

A- Cólico biliar.

B- Síndrome coledociano.

C- Cáncer de vesícula.

D- Fístula colecisto-digestiva.

---

5) ¿Qué tipo de hernia es la más frecuente en la población general?

A- Epigástrica.

B- Crural.

C- Inguinal indirecta.

D- Inguinal directa.

---

6) ¿Cuál de las siguientes medidas es útil para la prevención del Tromboembolismo Pulmonar postquirúrgico?

A- Antibiótico preoperatorio.

B- Kinesioterapia preoperatoria.

C- Movilización precoz y heparino profilaxis.

D- No movilizar al paciente en las primeras 48 horas.

---

7) El hamartoma de pulmón es:

A- Maligno.

B- Benigno.

C- Secundario a un traumatismo.

D- Teratoma.

---

8) Un ejecutivo de una gran empresa, de 40 años y sin antecedentes de interés, acude al servicio de urgencias por presentar un dolor brusco y de gran intensidad, localizado en el epigastrio que ha comenzado una hora antes y no cede. A la exploración, el paciente está pálido, sudoroso, hipotenso, con respiración superficial; el abdomen tenso y muy doloroso a la palpación superficial, mostrando desaparición de la matidez hepática a la percusión. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- A- Apendicitis aguda.
  - B- Pancreatitis aguda.
  - C- Perforación gástrica.
  - D- Colecistitis aguda.
- 

9) ¿Cuál de los siguientes es un criterio de Ranson?

- A- Ferremia.
  - B- Linfopenia.
  - C- Hematocrito.
  - D- Calciuria.
- 

10) ¿Cuál es el síntoma más común en la fisura anal?

- A- Hemorragia.
  - B- Dolor.
  - C- Secreción purulenta.
  - D- Prurito.
- 

11) ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente de la ÚLCERA PÉPTICA?

- A- Pérdida de peso.
  - B- Anorexia selectiva.
  - C- Dolor epigástrico.
  - D- Pirosis y regurgitación.
- 

12) ¿Cuál es la causa más frecuente de hiperparatiroidismo secundario?

- A- Insuficiencia renal aguda.
  - B- Insuficiencia renal crónica.
  - C- Mieloma múltiple.
  - D- Enfermedad de Paget ósea.
- 

13) Los criterios tomográficos de Balthazar, ¿en qué patología se aplican?

- A- Tumor de páncreas.
  - B- Pancreatitis aguda.
  - C- Pancreatitis crónica.
  - D- Tumor de vía biliar distal.
- 

14) ¿Por qué se caracterizan las QUEMADURAS DE TIPO A o de 1° Grado?

- A- Comprometer la epidermis y la dermis en su totalidad.
  - B- Presentar dolor y eritema.
  - C- Tener la piel anémica y pigmentada por carbonización.
  - D- Palpar una superficie resistente con consistencia de caucho.
- 

15) ¿Cuál es el método por imágenes de elección para el estudio de la colelitiasis?

- A- Resonancia magnética.
  - B- Tomografía abdominal.
  - C- Radiografía.
  - D- Ecografía.
-

16) ¿Cuáles son las úlceras duodenales que sangran en forma masiva con mayor frecuencia?

- A- Postbulbares.
  - B- De la cara anterior.
  - C- De la cara posterior.
  - D- Del borde superior.
- 

17) ¿Cuál es la principal causa de peritonitis generalizada?

- A- Embarazo ectópico.
  - B- Enfermedad pélvica inflamatoria.
  - C- Apendicitis aguda.
  - D- Colecistitis aguda.
- 

18) Los abscesos perianales se originan frecuentemente en:

- A- Glándulas perianales inter esfinterianas.
  - B- Erosiones perianales.
  - C- Hemorroides trombosadas.
  - D- Enfermedad de Crohn.
- 

19) Una paciente de 57 años consulta por dolor epigástrico tipo cólico luego de la ingesta de comidas ricas en grasas, que se repitió en varias oportunidades. Tiene el antecedente de colecistectomía laparoscópica siete años antes. El examen físico es normal y el laboratorio muestra: GR 4.300.000 mm<sup>3</sup>, HTO 42%, Hb 12,9 mg/dL, glóbulos blancos 4.500 mm<sup>3</sup>, bilirrubina total 3,5 md/dL, bilirrubina directa 3,1 mg/dL, GPT 120 UI/L, GOT 115 UI/L, FA 690 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A- Hepatitis viral.
  - B- Hepatitis tóxica.
  - C- Litiasis coledociana con obstrucción canalicular.
  - D- Síndrome postcolecistectomía.
- 

20) ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta?

- A- Síndrome de Mallory-Weiss.
  - B- Esofagitis.
  - C- Várices esofágo-gástricas.
  - D- Úlcera péptica.
- 

21) ¿Qué dato semiológico presente en un adolescente puede orientar su diagnóstico hacia el de colelitiasis?

- A- Dolor preingesta localizado en epigastrio.
  - B- Intolerancia ante la ingestión de productos grasos.
  - C- Diarrea inducida por productos con alta concentración de lactosa.
  - D- Meteorismo persistente.
- 

22) ¿Cuál es el cáncer de tiroides más frecuente?

- A- Papilar.
  - B- Folicular.
  - C- Medular.
  - D- Anaplásico.
- 

23) La causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio es:

- A- Hipercalcemia.
- B- Litiasis biliar.
- C- Alcohol.
- D- Hiperlipidemia.

24) En un paciente con sospecha de ABDOMEN AGUDO OBSTRUCTIVO el examen físico nos muestra:

- A- Abdomen excavado.
  - B- Contractura generalizada.
  - C- Matidez a la percusión.
  - D- Aumento de ruidos hidroaéreos.
- 

25) El patrón electrocardiográfico QRS de duración mayor a 0,12 seg con morfología QS en V1 con R ancha y empastada en V6 corresponde a:

- A- Bloqueo completo de rama izquierda.
  - B- Bloqueo completo de rama derecha.
  - C- Bloqueo aurículo-ventricular de primer grado.
  - D- Bloqueo bifascicular.
- 

26) ¿En cuál de los siguientes procesos es característica la presencia de un soplo diastólico?

- A- Estenosis aórtica.
  - B- Prolapso mitral.
  - C- Mixoma auricular.
  - D- Rotura del músculo papilar.
- 

27) Ante un paciente con ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, secreciones mucosas, adenopatías preauriculares y el antecedente de un cuadro de vías aéreas superiores, usted pensaría en:

- A- Conjuntivitis bacteriana.
  - B- Conjuntivitis micótica.
  - C- Conjuntivitis alérgica.
  - D- Conjuntivitis vírica.
- 

28) Una de las características del síncope es:

- A- Inicio gradual.
  - B- Duración prolongada.
  - C- Hipoperfusión cerebral focal.
  - D- Recuperación espontánea completa.
- 

29) La enfermedad de Addison se asocia con:

- A- Descenso de ACTH plasmática.
  - B- Aumento de aldosterona plasmática.
  - C- Hipopigmentación generalizada.
  - D- Descenso de cortisol plasmático.
- 

30) ¿Qué situación produce una anemia regenerativa?

- A- Invasión medular por Leucemia.
  - B- Deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12.
  - C- Deficiencia de eritropoyetina.
  - D- Anemia hemolítica.
- 

31) El edema en esclavina es característico de:

- A- Síndrome nefrótico.
  - B- Insuficiencia cardíaca aguda.
  - C- Síndrome de vena cava superior.
  - D- Cirrosis descompensada.
-

32) Mujer de 70 años que consulta por cuadro de poco tiempo [...] Muestra una intensa pigmentación melánica cutáneo-mucosa [...] hiperpotasemia e hipoglucemia. Con estos datos, la sospecha diagnóstica será:

A- Insulinoma.

B- Insuficiencia suprarrenal primaria crónica.

C- Coma mixedematoso.

D- Crisis tirotóxica.

---

33) Paciente de 25 años de edad, con antecedentes de asma intermitente leve, que presenta crisis de broncorreactividad con el ejercicio por lo que decide consultar. Usted indica:

A- Evitar ejercicio.

B- Corticoesteroides orales a bajas dosis en tratamiento continuo.

C- Agonistas beta2 de corta acción más antileucotrienos antes del ejercicio.

D- Agonistas beta2 de larga acción más teofilina.

---

34) ¿Cuál de éstos es criterio de posible benignidad en una lesión pigmentada melanocítica?

A- Variaciones de color.

B- Diámetro superior a 0,5cm en crecimiento.

C- Sangrado.

D- Bordes simétricos.

---

35) ¿Qué anomalía sospecha cuando un paciente tiene diarrea después de la ingesta de leche?

A- Déficit de sacarasa.

B- Enfermedad celíaca.

C- Déficit de lactasa.

D- Déficit de isomaltasa.

---

36) De acuerdo a los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿cuál es uno de los criterios mayores?

A- Edema de miembros inferiores.

B- Disnea de esfuerzo.

C- Hepatomegalia.

D- Reflujo hepatoyugular positivo.

---

37) ¿Qué dato se encuentra en el HIPERALDOSTERONISMO?

A- Hipopotasemia por pérdida urinaria.

B- Deshidratación con hiponatremia.

C- Acidosis metabólica.

D- Hipotensión arterial ortostática.

---

38) ¿Cuál de las siguientes es causa de trombocitopenia periférica?

A- Aplasia medular.

B- Leucemia aguda.

C- Metástasis óseas.

D- Hiperesplenismo.

---

39) La infección urinaria baja presenta:

A- Frecuencia mayor en mujeres.

B- Dolor lumbar.

C- Fiebre mayor a 39°.

D- Cilindros leucocitarios en orina.

---

40) ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente de los tumores renales?

- A- Dolor lumbar.
  - B- Hematuria.
  - C- Hipercalcemia.
  - D- Hipertensión arterial.
- 

41) Una paciente de 78 años es traída por los familiares a la guardia por hematemesis. Sólo refieren que padece artrosis, por lo que ingiere diclofenac. A la exploración física: PA 100/60 mmHg, FC 100/min, con palidez generalizada. ¿Cuál es la etiología más frecuente en este cuadro de hemorragia digestiva?

- A- Esofagitis erosiva.
  - B- Várices esofágicas.
  - C- Síndrome de Mallory-Weiss.
  - D- Úlcera péptica.
- 

42) ¿Cuál de las siguientes situaciones produce hiperuricemia por sobreproducción de uratos?

- A- Insuficiencia renal crónica.
  - B- Enfermedad renal poliquística.
  - C- Cetoacidosis diabética.
  - D- Enfermedad mieloproliferativa.
- 

43) Un hombre de 45 años de edad con antecedentes de poliquistosis renal consulta en la guardia por cefalea intensa de comienzo súbito. Al examen usted sólo encuentra rigidez de nuca, sin fiebre. Los signos vitales son normales. Debe sospechar de:

- A- Meningitis bacteriana.
  - B- Hemorragia subaracnoidea.
  - C- Estatus migrañoso.
  - D- Subluxación cervical.
- 

44) Paciente de 45 años de edad, internado por tumor cerebral, que presenta durante la internación rápido deterioro del sensorio por lo que usted acude a la sala a evaluar al paciente. Al examen corrobora que el paciente no responde a estímulos verbales, responde a estímulos nociceptivos con flexión de los miembros; presenta la pupila izquierda de 6mm de diámetro sin reactividad a la luz y alteración de la respiración. El manejo inicial del paciente es:

- A- Realizar intubación orotraqueal, conexión a asistencia ventilatoria mecánica y realización de tomografía de cerebro de urgencia.
  - B- Realización de estudios toxicológicos para encontrar causa del coma.
  - C- Administración de naloxona y suero glucosado ante la posibilidad de consumo de narcóticos o hipoglucemia.
  - D- Esperar la decisión del especialista (neurólogo/neurocirujano) antes de tomar alguna conducta.
- 

45) ¿Cuál es el tratamiento de elección en una fibrilación auricular aguda, con descompensación hemodinámica, sin cardiopatía estructural?

- A- Amiodarona.
  - B- Betabloqueantes.
  - C- Antiagregación.
  - D- Cardioversión eléctrica.
- 

46) ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes (triada de Beck) en el taponamiento cardíaco?

- A- Hipotensión arterial, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos hipofonéticos.
  - B- Edema en miembros inferiores, disnea, cardiomegalia.
  - C- Pulso paradójico, hipotensión arterial, disnea.
  - D- Disnea, tos, fiebre.
-

47) Paciente de 28 años de edad, consulta por presentar lesiones en piel con pápula central, redondeadas y ovales, bordeadas por franja eritematosa, muy pruriginosas, en brazos, región del tórax y muslo, de 10 horas de evolución posterior a automedicación con amoxicilina por dolor de garganta. No presenta otras lesiones ni en cara ni en mucosas. Su diagnóstico es urticaria por fármacos. ¿Qué tratamiento sugiere para este paciente?

A- Los antihistamínicos orales son suficientes para este caso, control clínico en caso de no presentar mejoría y suspensión de antibiótico.

B- Es necesario agregar una dosis de corticoide al esquema anterior.

C- Se debe tratar con antihistamínicos y corticoides por vía sistémica hasta la desaparición de al menos 50% de las lesiones y suspender el antibiótico.

D- Se debe comenzar con adrenalina por el alto riesgo de anafilaxia.

---

48) ¿Cuáles son las causas predominantes de las úlceras pépticas?

A- Pancreatitis crónica y cirrosis hepática por alcohol.

B- *Helicobacter pylori* y antiinflamatorios no esteroideos.

C- Nefrolitiasis e insuficiencia renal crónica.

D- Hiperparatiroidismo primario y mastocitosis generalizada.

---

49) Ante un paciente pediátrico con shock ¿Cuál de los siguientes signos es de aparición más precoz?

A- Depresión de la conciencia.

B- Hipoventilación de las bases pulmonares.

C- Hipotensión arterial.

D- Relleno capilar mayor a 2 segundos.

---

50) Niño de 18 meses de edad, con calendario de vacunas completo hasta la fecha, que consulta en el servicio de urgencias por tumefacción de la rodilla derecha tras jugar en el parque, sin traumatismo evidente. En la anamnesis dirigida, la madre refiere que un tío de ella tenía problemas similares. La exploración ecográfica es compatible con hemartrosis y en la analítica sólo destaca un alargamiento del KPTT de 52'' (normal 25-35''). ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica más probable?

A- Síndrome de Marfan.

B- Enfermedad de Von-Willebran.

C- Enfermedad de Ehlers-Danlos.

D- Hemofilia.

---

51) Erupción en alas de mariposa, manifestaciones musculoesqueléticas (artritis, miositis), serositis, hepatoesplenomegalia, pericarditis y signos de afectación neurológica, son manifestaciones de:

A- Lupus.

B- Artritis reumatoidea juvenil.

C- Dermatomiositis.

D- Esclerodermia.

---

52) ¿Cuál de los siguientes tratamientos sería más apropiado para un paciente de 10 años con hematuria macroscópica, edema en párpados y dorso de manos, y tensión arterial de 150/110?

A- Transfusión de glóbulos rojos.

B- Furosemida 2mg/kg/dosis.

C- Aporte libre de líquidos por vía oral.

D- Transfusión de plaquetas.

---

53) ¿Cuál de los siguientes alimentos puede gatillar anafilaxia en edad pediátrica con más frecuencia?

A- Maní y frutos secos.

B- Verduras de hoja.

C- Frutos carnosos.

D- Arroz.

---

54) El órgano más afectado por la desnutrición durante los primeros meses de vida es:

- A- El pulmón.
  - B- El corazón.
  - C- El riñón.
  - D- El cerebro.
- 

55) Los vómitos en el lactante mayor de 6 meses suele relacionarse con:

- A- Sobrealimentación.
  - B- Reflujo gastroesofágico.
  - C- Hipertrofia de píloro.
  - D- Atresia de esófago.
- 

56) ¿Cuál es el criterio válido para diagnosticar sinusitis aguda, como complicación bacteriana del resfrío común?

- A- Clínica (Duración de los síntomas y/o aparición de nuevos signos).
  - B- Radiológico: alteración de celdillas etmoidales y senos maxilares.
  - C- VSG elevada.
  - D- Tomografía de senos, con cortes coronales.
- 

57) Una niña de 13 meses de vida presenta diarrea desde los 8 meses de edad. A los 6 meses de vida se introdujeron harinas en su alimentación. Entre los estudios solicitados se detectó anemia, hipoalbuminemia y pérdida excesiva de grasas en materia fecal. Entre los diagnósticos probables. ¿Cuál sería el más apropiado?

- A- Alergia a proteínas lácteas.
  - B- Gastroenteritis infecciosa.
  - C- Enfermedad celíaca.
  - D- Gastroenteritis eosinofílica.
- 

58) La diarrea aguda prevalente durante el período de lactante se caracteriza preferentemente por:

- A- Presentar sangre habitualmente en las deposiciones.
  - B- Acompañarse de vómitos, cólicos y mal estado general.
  - C- Requerir frecuentemente hospitalización para recuperar los nutrientes perdidos.
  - D- Ser autolimitada y requerir medidas de sostén y aporte hidrosalino adecuado.
- 

59) Un niño de tres años de edad ingresa en el hospital con un síndrome hemolítico-urémico (SHU) aparecido después de tres días de diarrea sanguinolenta sin fiebre. ¿Cuál es el agente causal más probable de este síndrome diarreico asociado a SHU?

- A- Rotavirus.
  - B- Yersinia enterocolítica.
  - C- Giardia lamblia.
  - D- Escherichia coli O157:H7.
- 

60) Señalar lo correcto en relación con el síndrome nefrótico:

- A- Es una patología más frecuente en adultos que en niños.
  - B- Debido a edema periorbitario, puede confundirse inicialmente con un trastorno alérgico.
  - C- Es común la presencia de macrohematuria e hipertensión.
  - D- La principal complicación del síndrome nefrótico son los fenómenos tromboembólicos.
- 

61) Un niño de dos años ingirió accidentalmente una pila alcalina, tipo botón, hace una hora y por estudio radiográfico se encuentra ubicada en una de las estrecheces fisiológicas del esófago. Usted considera que la conducta terapéutica es:

- A- Ninguna, ya que no considera que se trate de una situación de riesgo para el paciente.
- B- Indica extracción endoscópica inmediata.
- C- Seguimiento radiológico hasta su eliminación.
- D- Medica con proquinéticos para estimular la contractilidad esofágica y favorecer el pasaje de la pila al estómago.



62) El SÍNDROME NEFRÓTICO en pediatría puede ser primario o secundario. La forma primaria más frecuente es:

- A- Glomerulonefritis membranoproliferativa.
  - B- Glomerulonefritis postestreptocócica.
  - C- Alteraciones de la membrana basal glomerular.
  - D- Enfermedad por cambios mínimos.
- 

63) Una de las causas más frecuentes de abdomen agudo en el LACTANTE es:

- A- Apendicitis aguda.
  - B- Hernia umbilical.
  - C- Invaginación intestinal.
  - D- Colecistitis aguda.
- 

64) Ante un bebé de 1 mes, que súbitamente comienza con vómitos no biliosos, justo luego de ingerir leche, con ictericia leve, cuya madre le relata que después de vomitar el niño se muestra hambriento, usted sospecha:

- A- Estenosis hipertrófica del píloro.
  - B- Gastroenteritis aguda.
  - C- Invaginación intestinal.
  - D- Oclusión intestinal.
- 

65) Ante un niño que súbitamente presenta petequias, púrpura palpable en especial en miembros inferiores, fiebre y estado tóxico, el primer diagnóstico a considerar es el de:

- A- Púrpura de Schonlein Henoch.
  - B- Meningococcemia.
  - C- Púrpura trombocitopénica inmune.
  - D- Leucemia linfoblástica aguda.
- 

66) El adenocarcinoma de próstata es una enfermedad frecuente en el sexo masculino. La indicación más frecuente para el tratamiento de la enfermedad localizada es:

- A- Prostatectomía radical.
  - B- Hormonoterapia.
  - C- Quimioterapia.
  - D- Resección transuretral.
- 

67) Un niño con diarrea, que presenta: pulso normal, disminución del volumen urinario, está sediento, con examen físico normal, tiene:

- A- Deshidratación grave.
  - B- Deshidratación moderada.
  - C- Deshidratación leve.
  - D- No está deshidratado.
- 

68) La carencia de folatos antes y durante el embarazo puede producir en el feto (marcar lo correcto):

- A- Hidrops fetal.
  - B- Defectos del tubo neural.
  - C- Trastornos hemorrágicos.
  - D- Deformidades faciales.
-

69) Ante un paciente de 2 años de edad, que presenta palidez y oligoanuria de inicio súbito, con antecedentes de una diarrea sanguinolenta que se acompañó de fiebre, usted sospecha:

A- Glomerulonefritis postestreptocócica.

**B- Síndrome urémico-hemolítico.**

C- Infección urinaria.

D- Síndrome nefrótico.

---

70) La leucocoria en niño es la presentación inicial de:

**A- Retinoblastoma.**

B- Condrosarcoma.

C- Glioma óptico.

D- Leucemia.

---

71) ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en la edad pediátrica?

A- Comunicación interauricular.

B- Coartación de aorta.

C- Persistencia del conducto arterioso.

**D- Comunicación interventricular.**

---

72) Las lesiones elementales características de VARICELA NO COMPLICADA son:

A- Costras en piel y mucosas.

B- Máculas y pápulas purpúricas heteromorfas.

**C- Máculas, pápulas, vesículas y costras.**

D- Máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras.

---

73) El parto se produce mediante fenómenos activos: contracciones uterinas y pujos. ¿Cuál de los siguientes es otro fenómeno activo?

A- Modificaciones del cuello uterino.

B- Contracciones de músculos elevadores del ano.

**C- Formación y ampliación del segmento inferior.**

D- Expulsión de los limos.

---

74) ¿Cuál de los siguientes hallazgos están presentes en el síndrome de ovario poliquístico?

**A- Hirsutismo.**

B- Hipertensión arterial.

C- Disminución de la testosterona.

D- Hiperplasia suprarrenal.

---

75) De todas las masas anexiales diagnosticadas en el embarazo, como malignas, la más frecuente es:

**A- Disgerminoma.**

B- Cistoadenocarcinoma seroso.

C- Cistoadenocarcinoma mucinoso.

D- Tumor de células granulosas.

---

76) La localización más frecuente del embarazo ectópico es:

A- Porción ístmica de la trompa.

B- Porción intersticial de la trompa.

**C- Porción ampular de la trompa.**

D- Porción intramural.

---

77) Lo consulta una mujer de 28 años, sana, que cursa la semana 11 de su segundo embarazo. Le pregunta si puede colocarse la vacuna antigripal, ya que se la han ofrecido en su trabajo. Usted contesta:

- A- Que la vacuna contra la gripe está contraindicada en el embarazo.
  - B- Que solo se indica en paciente inmunodeprimidas.
  - C- Que solo se indica en pacientes que viven en zonas endémicas.
  - D- Que está indicada en mujeres a partir del primer trimestre.
- 

78) Paciente de 25 años, gestas: 1, paras: 1. Refiere dolor abdominal de comienzo brusco de 3 hs de evolución, fiebre de 38°C, leucorrea escasa con olor fétido verdoso. Refiere utilizar como método anticonceptivo dispositivo intrauterino desde hace 2 años. ¿Qué diagnóstico sospecha?

- A- Enfermedad pélvica inflamatoria.
  - B- Embarazo ectópico.
  - C- Quiste hemorrágico.
  - D- Infección urinaria.
- 

79) ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos produce Síndrome de Mondor?

- A- Peptoestreptococo.
  - B- Pseudomona aeruginosa.
  - C- Clostridium welchii.
  - D- Clostridium tetani.
- 

80) Paciente de 35 años cursando embarazo de 32 semanas de gestación, consulta a la guardia con genitorragia roja oscura, al examen físico se constata: TA 180/120, hipertensión uterina, latidos cardíacos fetales 100/minuto. ¿Cuál sería la conducta correcta?

- A- Estabilización de la TA y monitoreo fetal.
  - B- Solicita laboratorio con perfil de preeclampsia y ecografía doppler.
  - C- Cesárea de urgencia.
  - D- Internación en UTI para completar maduración pulmonar con estricto control de TA.
- 

81) La mayor parte del incremento de peso durante el embarazo no patológico es atribuible al aumento del:

- A- Líquido intracelular.
  - B- Anabolismo lipídico.
  - C- Tamaño del útero y su contenido, y de las mamas.
  - D- Anabolismo hidrocarbonado.
- 

82) ¿Cuál es la fractura más frecuente asociada a partos dificultosos?

- A- Clavícula.
  - B- Húmero.
  - C- Radio.
  - D- Tibia.
- 

83) El síntoma más común de cáncer de endometrio es:

- A- Amenorrea.
  - B- Secreción purulenta.
  - C- Dolor en hipogastrio.
  - D- Metrorragia.
- 

84) La medicación local más efectiva indicada ante el prurito vulvar por liquen escleroso es:

- A- Estrógenos.
- B- Progesterona.
- C- Estrógenos conjugados equinos.
- D- Corticoides locales.

85) ¿Cuál de los siguientes patrones hormonales es el más frecuente durante el climaterio?

- A- Gonadotropinas disminuidas, y estrógenos y progesterona disminuidos.
  - B- Gonadotropinas disminuidas, y progesterona elevada.
  - C- Gonadotropinas elevadas, y hormonas ováricas disminuidas.
  - D- Gonadotropinas elevadas, estrógenos y progesterona elevadas.
- 

86) ¿Cuál es la causa más frecuente de desprendimiento prematuro de placenta?

- A- Traumatismo.
  - B- Brevedad del cordón umbilical.
  - C- Polihidramnios.
  - D- Pre eclampsia.
- 

87) ¿Cuál es la causa más frecuente de aborto temprano?

- A- Alteraciones cromosómicas.
  - B- Deficiencias hormonales.
  - C- Miomatosis uterina.
  - D- Toxoplasmosis.
- 

88) ¿Cuál es la causa más frecuente de cáncer de cuello uterino?

- A- Alcoholismo.
  - B- Multiparidad.
  - C- Virus papiloma humano.
  - D- Tabaquismo.
- 

89) ¿Cuál de estas medidas es útil para disminuir el riesgo de parálisis cerebral en el feto, ante una amenaza de parto pre-término?

- A- Betamiméticos IV administrados con bomba de infusión.
  - B- Nifedipina oral en altas dosis.
  - C- Corticoides de acción prolongada.
  - D- Sulfato de magnesio endovenoso.
- 

90) El tumor de ovario más común que se presenta en la infancia es:

- A- Tumor de células de la granulosa.
  - B- Disgerminoma.
  - C- Teratoma.
  - D- Arrenoblastoma.
- 

91) Paciente de 25 años que presenta embarazo de 38 semanas, concurre a la consulta por dolor tipo cólico abdominal. Al examen constata contracciones uterinas, frecuencia cardíaca fetal de 150 latidos por minuto, al tacto vaginal se constata cuello borrado centrado 4cm de dilatación. Usted hace diagnóstico de:

- A- Amenaza de parto prematuro.
  - B- Cólico intestinal.
  - C- Trabajo de parto.
  - D- Infección urinaria.
- 

92) ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al término METRORRAGIA?

- A- Hemorragia proveniente del útero sin relación con el ciclo.
  - B- Hemorragia proveniente de cualquier lugar del tracto genital sin relación con el ciclo.
  - C- Hemorragia en relación con el ciclo.
  - D- Pérdida sanguínea postcoital.
-

93) En una mujer postmenopáusica con hemorragia uterina anormal, la actitud diagnóstica a seguir es:

- A- **Legrado uterino fraccionado.**
  - B- Administración de estrógenos y gestágenos y luego legrado.
  - C- Administración de gestágenos para controlar la hemorragia.
  - D- Hacer histeroscopia solamente.
- 

94) ¿La aparición de kernicterus del recién nacido (RN) se asocia con cuál de estas patologías?

- A- Infección connatal.
  - B- Rotura prematura y precoz de membranas.
  - C- **Hiperbilirrubinemia por incompatibilidad sanguínea materno-fetal.**
  - D- Diabetes gestacional.
- 

95) ¿Cuáles son las INFECCIONES BACTERIANAS más frecuentes que complican el embarazo?

- A- De piel y tejidos blandos.
  - B- **Del tracto urinario.**
  - C- Respiratorias.
  - D- Digestivas.
- 

96) Paciente cursando embarazo de 8 semanas consulta por genitorragia escasa, roja, a la especuloscopia se objetiva cuello sano, cerrado. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

- A- Aborto incompleto.
  - B- **Amenaza de aborto.**
  - C- Aborto completo.
  - D- Aborto séptico.
- 

97) ¿Cuándo el profesional de la salud puede actuar sin el consentimiento informado del paciente?

- A- **Cuando mediere grave peligro para la salud pública.**
  - B- Cuando mediere una situación de emergencia, con grave peligro para la salud incluso cuando el paciente puede prestar su consentimiento por sí mismo.
  - C- Cuando el paciente se encuentre en una situación de emergencia, con grave peligro para la salud incluso cuando el paciente no puede expresar su consentimiento, pero si puede hacerlo un pariente.
  - D- Cuando el paciente se encuentre con la posibilidad de poder rechazar el tratamiento indicado.
- 

98) Usted siendo profesional de la salud ¿Quién tiene permitido solicitarle una historia clínica?

- A- El paciente y su representante legal.
  - B- **El paciente y su representante legal, cónyuge o persona que conviva con el paciente, los médicos y otros profesionales del arte de curar.**
  - C- Solo otro médico.
  - D- Solo el cónyuge.
- 

99) Uno de los derechos del paciente es la "Autonomía de la Voluntad", esto le permite al paciente:

- A- **Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa.**
  - B- Solicitar al profesional de la salud la destrucción total de la historia clínica la cual el paciente es el titular.
  - C- En caso de extrema gravedad y situación de emergencia del paciente, imponerle al médico que interviene un tratamiento determinado obre su cuerpo.
  - D- Solicitarle al médico medicamentos que no corresponden con ningún diagnóstico determinado realizado en el paciente.
-

100) Se entiende por Consentimiento Informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada respecto a:

A- Su estado de salud.

B- Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos.

C- Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos; los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles.

D- Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos; los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos y las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.